

Terapia Fluídica: Apresentação de um Instrumento de Avaliação

Raphael Vivacqua Carneiro^{1,a} & Clóvis Aurélio Vervloet¹

¹ Grupo de Pesquisa Lampejo – Comunidade Espírita Esperança, Vitória, ES.

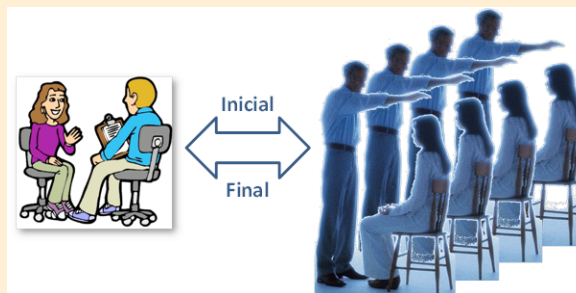
e-mail: ^acarneiro.raaphael@gmail.com

(Recebido em 15 de Fevereiro de 2018, publicado em 10 de Abril de 2018).

Trabalho apresentado no 13o ENLIHPE, ocorrido nos dias 26 e 27 de agosto de 2017, com apoio da USE e CCDPE.

RESUMO

Denominamos *Terapia Fluídica* a aplicação do magnetismo humano-espiritual de forma sistemática, visando à melhoria do bem-estar físico e espiritual de quaisquer indivíduos, como parte dos processos de *Atendimento Espiritual no Centro Espírita*, preconizados pela FEB. Grande número de relatos orais atestam os benefícios recebidos por pessoas que se submeteram de boa vontade à Terapia Fluídica. Este trabalho tem por objetivo apresentar um instrumento de avaliação do serviço de Terapia Fluídica e analisar os dados que foram coletados numa instituição espírita em Vitória, ES. Investigamos indicadores da Terapia Fluídica e seus reflexos na percepção de bem-estar das pessoas atendidas, incluindo saúde geral, ansiedade, qualidade de vida e dor. Selecionamos como amostra de pesquisa as pessoas que procuram o Atendimento Espiritual no Centro Espírita e que mostram sinais de ansiedade ou depressão, ou que apresentam problemas físicos cuja causa não se consegue diagnosticar, ou que persistem mesmo após tratamento médico. Aplicando o instrumento de avaliação antes do início do tratamento de Terapia Fluídica e após a conclusão do ciclo de seis encontros semanais de tratamento, constatamos que os principais indicadores pesquisados apresentaram melhoras estatisticamente significantes ($p < 0,05$), com variações positivas de 44% a 60%.



PALAVRAS-CHAVE: Terapia fluídica, magnetismo humano-espiritual, passe espírita.

DOI: [10.22568/jee.v6.artn.010203](https://doi.org/10.22568/jee.v6.artn.010203)

I INTRODUÇÃO

Neste artigo, denominamos *Terapia Fluídica* a aplicação do magnetismo humano-espiritual (KARDEC, 1868), de forma sistemática, visando à melhoria do bem-estar físico e espiritual de quaisquer indivíduos, como parte dos processos de *Atendimento Espiritual no Centro Espírita*, preconizados pela FEB (2006). Consideramos a expressão *Terapia Fluídica* mais adequada do que a palavra *passe*, tendo em vista que a primeira abrange um conceito mais amplo, enquanto a segunda foi criada pelos magnetizadores, no início do século XIX, para designar um método específico de transmissão do magnetismo pelo movimento das mãos (DELEUZE, 1825). Posteriormente o termo passou a ser empregado também como figura de linguagem *sinédoque*, em que o mais específico representa o mais geral.

As origens da Terapia Fluídica remontam à Antiguidade. Há relatos do seu uso na Caldeia, no Egito, em Roma, na Palestina (DELANNE, 1885). Nos séculos XVIII e XIX, ela ganhou repercussão na sociedade europeia, a partir dos trabalhos do médico Franz MESMER (1779) e dos seus continuadores. Em meados do século XIX, os trabalhos de Allan Kardec constataram a comunhão de esforços entre os Espíritos benfeitores e as pessoas que se dispõem a aplicar a Terapia Fluídica. Por este

motivo, a sua prática foi prontamente assimilada pelo Espiritismo no Brasil, desde os seus primórdios, na segunda metade do século XIX, até os dias atuais, obtendo grande aceitação.

Grande número de relatos orais atestam os benefícios recebidos por pessoas que se submeteram de boa vontade à Terapia Fluídica. Entretanto, não há uma avaliação sistemática quanto ao impacto no bem-estar dos indivíduos que a recebem nas instituições espíritas.

I.1 Objetivo

Este trabalho tem por objetivo apresentar um instrumento de avaliação do serviço de Terapia Fluídica e analisar os resultados que foram obtidos numa instituição espírita, em Vitória, ES.

I.2 Trabalhos Correlatos

Diversas pesquisas científicas buscam validar a eficácia de terapias alternativas ou complementares que se baseiam na transmissão de bioenergias de seres humanos a outros seres vivos, em diferentes contextos socioculturais. BENOR (2001) avaliou as chamadas “curas espirituais” em 191 estudos controlados e considerou 43,4% casos positivos, com evidência significativa ($p <$



0,01). KELLER & BZDEK (1986) investigou os efeitos do “toque terapêutico” em 60 pacientes com dor de cabeça tensional e constatou que 90% dos pacientes tiveram melhora significativa quando comparados ao grupo placebo. BIROCCO *et al.* (2012) investigou os efeitos da aplicação de “Reiki” em pacientes de câncer e concluiu que houve melhoras nos indicadores de ansiedade e dor. LUCCHETTI *et al.* (2013) avaliou os efeitos do passe espírita no crescimento de culturas de bactérias e concluiu que houve uma efetiva inibição do seu crescimento.

O presente trabalho visa contribuir neste campo de pesquisa por meio da verificação da eficácia da terapia complementar no contexto de uma instituição espírita.

II METODOLOGIA

A presente pesquisa empírica trata-se de um estudo descritivo utilizando instrumentos de comparação das impressões do mesmo sujeito antes e depois de submetido à terapia fluídica. Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva e teste de diferença de médias em amostras pareadas. A seguir descrevemos os critérios de seleção da amostra, o cenário onde o estudo foi realizado e os instrumentos de coleta de dados utilizados.

II.1 Seleção da Amostra

Neste trabalho de pesquisa, o local escolhido para a coleta de dados foi a Comunidade Espírita Esperança, situada em Vitória, ES. Trata-se de uma instituição fundada em 1982 e adesa à Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Desde a sua fundação, ela oferece gratuitamente ao público espírita e não espírita, serviços de Atendimento Espiritual, incluindo a Terapia Fluídica. Nessa instituição, a Terapia Fluídica é realizada em duas modalidades, em ambientes distintos: 1) na Câmara de Passes; e 2) na sala dos Grupos de Terapia Fluídica.

Na Câmara de Passes, a Terapia Fluídica é ofertada ao público geral, logo após o término de cada palestra pública doutrinária. Não há identificação das pessoas que se submetem ao serviço, nem conhecimento das suas eventuais queixas de mal-estar físico ou espiritual. Tampouco há controle sobre os resultados obtidos. O atendimento na Câmara de Passes é feito em grupos de no máximo dez pessoas por vez e dura entre três e cinco minutos para cada grupo.

Diferentemente, os Grupos de Terapia Fluídica, salvo poucas exceções, atendem somente às pessoas que passam pelas etapas essenciais do Atendimento Espiritual na instituição e que são especificamente encaminhadas pela Coordenação Geral dos trabalhos. As etapas essenciais do Atendimento Espiritual são: 1) Recepção; 2) Entrevista individual; e 3) Ciclo de palestras.

A entrevista individual, com duração média de trinta minutos, é realizada nos moldes recomendados pela FEB (2006), no tópico *Atendimento Fraterno pelo Diálogo*. Ao final, o atendente convoca o atendido a participar do Ciclo de Palestras, que possui duração de seis encontros semanais e é especificamente voltado ao público que

está submetido ao Atendimento Espiritual na instituição. Usando a sua experiência e sensibilidade, o atendente assinala, numa Ficha de Atendimento (Figura 1), quais são as principais características relacionadas à pessoa atendida. Além disso, o atendente indica à Coordenação Geral dos trabalhos quais são as suas recomendações quanto ao encaminhamento desta pessoa às demais etapas do Atendimento Espiritual: 1) Psicoscopia; 2) Terapia Fluídica; 3) Terapia Espiritual; 4) Harmonização; ou 5) Grupo de Estudo. Dessa forma, a primeira via de encaminhamento da pessoa atendida a um dos Grupos de Terapia Fluídica, é a entrevista individual. O critério utilizado é a existência de um ou mais dos seguintes indícios: a) problemas físicos cuja causa os médicos não conseguem diagnosticar; b) problemas físicos que persistem mesmo após tratamento médico; c) sinais de ansiedade; ou d) sinais de depressão.

Outra via de encaminhamento aos Grupos de Terapia Fluídica parte da equipe de Psicoscopia, que realiza um trabalho nos moldes da técnica de *varredura medianímica*, descrita pelo pesquisador espírita PALHANO Jr. (1998). Nessa instituição pesquisada, diferentemente da proposta de Palhano Jr., o alvo da varredura medianímica não se situa à distância da equipe de médiuns, mas no mesmo recinto. Os médiuns, que *a priori* desconhecem as informações relativas ao alvo, anotam as suas percepções, enquanto a pessoa atendida recebe um passe com duração entre três e cinco minutos. Após o atendido retirar-se do recinto, o coordenador da equipe de Psicoscopia compila todas as percepções medianímicas, ressaltando as informações que são convergentes entre si e as características registradas pela entrevista individual. Usando a sua experiência e sensibilidade, o coordenador assinala, na própria Ficha de Atendimento, quais são as principais características espirituais relacionadas à pessoa atendida e quais são as suas recomendações quanto ao encaminhamento desta pessoa às demais etapas do Atendimento Espiritual: 1) Terapia Fluídica; 2) Terapia Espiritual; ou 3) Equipes Mediúnicas.

Por fim, a Coordenação Geral dos trabalhos, de posse das informações registradas nas Fichas de Atendimento, seleciona os indivíduos cujos casos lhe parecem mais propícios a receber a maior quota de benefício dos Grupos de Terapia Fluídica, limitando o número total à capacidade máxima comportada pelos três grupos existentes na instituição.

As estatísticas apuradas na instituição, de janeiro a dezembro de 2016, apontam o seguinte:

- Quantidade total de pessoas atendidas na entrevista individual: 673
- Quantidade total de pessoas atendidas na Psicoscopia: 222
- Quantidade total de pessoas encaminhadas aos Grupos de Terapia Fluídica: 102

Os encaminhamentos aos Grupos de Terapia Fluídica são feitos indistintamente para cada um dos três grupos existentes na instituição, que trabalham em diferentes



ATENDIMENTO FRATERO CEE	NOME:			CRACHÁ CEE:	
	Ocupação:			Idade:	F M
	Endereço:			Cidade:	☐ Vitória ☐ Vila Velha ☐ Serra
	Bairro:			Outra cidade:	
	Telefone:			Obs.:	
E-mail:					
ESCOLARIDADE COMPLETA ☐ Nenhuma ☐ Fundamental1 ☐ Fundamental2 ☐ Médio ☐ Superior ☐ Pós-graduação		ESTADO CIVIL ☐ Solteiro ☐ Casado ☐ União Estável ☐ Separado ☐ Viúvo Núm. filhos: PRIMEIRO TRATAMENTO NA CEE? ☐		QUEM ENCAMINHOU? ☐ Casa Espírita ☐ Espontâneo ☐ Psicoterapeuta ☐ Psiquiatra ☐ Outro médico ☐ Outro	
RELIGIÃO ☐ Espírita (Kardec) ☐ Católico ☐ Protestante/Evangélico ☐ Outra ☐ Não tem ou não declara (Neste caso): ☐ Crê em Deus ☐ Não crê em Deus		PARTICIPA DE ALGUMA COMUNIDADE RELIGIOSA? ☐ Sim ☐ Não Considera religião nas decisões pessoais? ☐ Semanalmente ☐ 2-3/semana ☐ Eventualmente ☐ Sempre ☐ Eventualmente ☐ Não ☐ Faz trabalho voluntário? ☐ Cargo em atividade religiosa?		FÉ EM DEUS É IMPORTANTE P/ VOCÊ? ☐ Sim ☐ Não ☐ Muito ☐ Pouco Hábito de meditar? ☐	
HÁBITO DE ORAR ☐ Diariamente ☐ Várias vezes ao dia ☐ Esporadicamente ☐ Nunca		SE ESPÍRITA Instituição: ☐ CEE Outra: ☐ ESDE Concluiu ☐ Local ☐ ESMED Concluiu ☐ Local		SE TRABALHADOR ESPÍRITA ☐ Qual a atuação atual? ☐ Faz culto no lar? ☐ Faz trabalho voluntário? ☐ Faz leituras edificantes por hábito? ☐ Assiste a palestras?	
SONO ☐ Normal ☐ Insônia ☐ Pesadelo ☐ Acorda cansado e/ou sono agitado ☐ Sonambulismo ☐ Terror noturno		PERCEPÇÕES/SENSAÇÕES ☐ Desconforto físico ☐ Desconforto espiritual ☐ Sensação de cabeça vazia ☐ Arrepios pelo corpo ☐ Dores sem causa ☐ Irritabilidade ☐ Desmaios ☐ Choro sem motivo ☐ Instabilidade emocional ☐ Pensamentos intrusivos e repetitivos ☐ Vê-se fora do corpo ☐ Formigamentos ☐ Sudorese ☐ Taquicardia ☐ Outros		ESTÁ EM TRATAMENTO ☐ Médico ☐ Psicoterapia ☐ Medicamentos psicotrópicos ☐ Homeopatia ☐ Acupuntura ☐ Outros QUEIXA:	
☐ DQ ☐ AD ☐ DG ☐ RM ☐ SP ☐ ICE		OBSERVAÇÕES DO ENTREVISTADOR ☐ Deseja conhecer a Doutrina Espírita ☐ Lar tranquilo/normal ☐ Lar em desarmonia ☐ Conflitos conjugais ☐ Conflitos pessoais ☐ Perda de ente querido ☐ Pede por outrem ☐ Problemas psicofísicos ☐ Quadro depressivo ☐ Distúrbio psíquico ☐ Sensibilidade mediúnica ☐ Desconforto mediúnico ☐ Outro		OBSERVAÇÕES ADICIONAIS DO ENTREVISTADOR Entrevistador Data 20	
☐ DQ ☐ AD ☐ DG ☐ RM ☐ SP ☐ ICE		PSICOSCOPIA ☐ Assédio espiritual ☐ Sensibilidade mediúnica ☐ Vingadores ☐ Oportunistas ☐ Subjugação ☐ Fascinação ☐ Adoecimento físico ☐ Vampirismo ☐ Perda fluidica ☐ Transtornos depressivos ☐ Transtornos alimentares		OBSERVAÇÕES ADICIONAIS DA PSICOSCOPIA Data 20 Núm. Participantes	
RETORNO Entrevistador Data 20		ENCAMINHAMENTO ☐ T. fluidica ☐ T. espiritual ☐ Harmonização ☐ Gr. estudo Concorda com: a mensagem ☐ o exame e/ou reunião mediúnica ☐ Melhorou? (O a 10 SEGUIMENTO ☐ Terapia fluidica ☐ Terapia espiritual ☐ Equipes mediúnicas			

Figura 1: Ficha de Atendimento adotada pela equipe de Atendimento Espiritual da Comunidade Espírita Esperança. Possui três seções, que são preenchidas em momentos distintos: a) Entrevista individual inicial; b) Psicoscopia; c) Entrevista individual de retorno.



horários e dias da semana. Em cada um dos grupos, os trabalhos ocorrem em ciclos, que possuem duração de seis encontros semanais, em sincronia com os Ciclos de Palestras. Salvo poucas exceções, cada pessoa atendida pelos Grupos de Terapia Fluídica participa de apenas um ciclo.

O presente trabalho de pesquisa selecionou como amostra todos os indivíduos que foram atendidos pelo Grupo Fonte Viva, que é um dos três Grupos de Terapia Fluídica existentes na instituição pesquisada, durante três ciclos de atendimento, no período de 01/12/2016 a 13/04/2017. O motivo da escolha do Grupo Fonte Viva na seleção da amostra da pesquisa é o fato de ele possuir um método operacional e um número de trabalhadores que facilitavam o trabalho de coleta de dados.

II.2 Método Operacional do Grupo Fonte Viva

O Grupo de Terapia Fluídica Fonte Viva possui uma equipe de 22 trabalhadores, os quais se subdividem, a cada ciclo de seis encontros semanais, em dois times atuantes de forma cooperativa, em ambientes distintos: a) Preparação; e b) Magnetização.

A fim de melhor contextualizar o papel de cada uma destas equipes, convém citar o codificador espírita, no tocante à atuação de quem doa e de quem recebe o fluido magnético:

Considerado como matéria terapêutica, o fluido tem que atingir a matéria orgânica, a fim de repará-la; pode então ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador, ou atraído pelo desejo ardente, pela confiança, numa palavra: pela fé do doente. Com relação à corrente fluídica, o primeiro age como uma bomba calcante e o segundo como uma bomba aspirante. Algumas vezes, é necessária a simultaneidade das duas ações; doutras, basta uma só (KARDEC, 1868, cap. XV, item 11).

A Equipe de Preparação é responsável por recepcionar as pessoas que receberão a Terapia Fluídica no dia e favorecer que cada uma delas atue como uma *bomba aspirante*, durante a sessão. Para tanto, cada atendente entabula um breve diálogo com o atendido, no intuito de dar-lhe as orientações básicas e fazê-lo sentir-se acolhido e bem-vindo. Após esse breve diálogo, o atendente anota, em formulário próprio, as suas impressões quanto ao estado em que se encontrava o atendido, antes do início da sessão, naquele dia. Em seguida, o atendido entra na sala de preparação. Nesse ambiente, ele é estimulado a desligar-se das apreensões cotidianas e concentrar-se num vídeo disponibilizado para fins de harmonização interior. O período total da preparação dura cerca de 15 minutos.

Simultaneamente ao período de preparação das pessoas que serão atendidas, a Equipe de Magnetização reúne-se na sala de Terapia Fluídica, a fim de efetuar a sua própria preparação, por meio de prece e exercícios de relaxamento. Esta etapa, que também dura cerca de 15 minutos, tem por objetivo favorecer que cada trabalhador da equipe atue como uma *bomba calcante*, durante a sessão.

Ao final do período de preparação, uma turma de pessoas atendidas, que não exceda o limite de dez indivíduos, entra na sala de Terapia Fluídica, onde a Equipe de Magnetização a aguarda, para dar início à sessão. Nessa sala, o ambiente é de penumbra, com música suave ao fundo. As seguintes atividades aí ocorrem: a) prece; b) relaxamento induzido por meio de sugestão verbal; c) magnetização humano-espiritual, por meio de passes e imposição de mãos; d) magnetização da água contida em recipientes individualizados, por meio de imposição de mãos; e) sugestão verbal final. A sugestão verbal realizada após a magnetização é recomendada por PALHANO Jr & SOUZA (1993). A duração total da sessão na sala de Terapia Fluídica é cerca de 30 minutos.

Após a sessão, cada atendido retira-se da sala de Terapia Fluídica, e passa por um breve diálogo final com um dos atendentes da Equipe de Preparação. Nesse momento, o atendido recebe orientações a serem observadas diariamente até o próximo encontro, incluindo: prece, leitura edificante, ingestão da água que foi magnetizada durante a sessão, prática do Evangelho no Lar. Após esse breve diálogo, o atendente anota, em formulário próprio, as suas impressões quanto ao estado em que se encontrava o atendido, após o término da sessão, naquele dia.

Num mesmo dia, o Grupo Fonte Viva atende, sequencialmente, a duas turmas de no máximo dez indivíduos cada. Cada turma passa por todas as etapas que aqui foram descritas.

Ao final dos trabalhos do dia, toda a equipe de trabalhadores reúne-se na sala de Terapia Fluídica por 15 minutos, a fim de realizar uma avaliação geral dos trabalhos do dia e uma prece de encerramento.

O Grupo Fonte Viva trabalha semanalmente, no mesmo dia da semana e horário. Durante os seis encontros semanais que compõem um ciclo de atendimento de Terapia Fluídica, ocorre um rodízio entre os integrantes da Equipe de Magnetização, de modo que, a cada encontro, as pessoas atendidas recebam a magnetização de trabalhadores distintos. Dessa forma, evita-se uma relação de dependência inconveniente entre atendido e atendente. Ao final dos seis encontros semanais, o grupo realiza uma reunião exclusiva para os seus trabalhadores, a fim de avaliar os trabalhos daquele ciclo que se encerra.

Na seção seguinte, descrevemos os instrumentos de coleta de dados para a pesquisa, os quais são aplicados pela Equipe de Preparação do Grupo Fonte Viva, nos momentos de interação com as pessoas atendidas, no início e ao final de cada encontro.

II.3 Instrumentos de Coleta de Dados

O objetivo destes instrumentos é prospectar dados sobre a percepção de saúde geral, ansiedade, qualidade de vida e dor das pessoas atendidas, antes e depois do período de realização da Terapia Fluídica.

Dando os devidos créditos, cabe informar que os instrumentos de coleta de dados utilizados nesta pesquisa (Figuras 2 e 3) foram inspirados, parcialmente, num trabalho em fase de elaboração pela AME - Associação Mé-



NOME: _____

DATA: ____/____/____ Nº CEE _____ Tel.: _____ WA()

E-mail: _____

EM GERAL VOCÊ DIRIA QUE SUA SAÚDE ESTÁ:				
Excelente	Muito Boa	Boa	Ruim	Muito Ruim
1	2	3	4	5

DURANTE AS ÚLTIMAS 6 SEMANAS:

Quanto foi incomodado?		Nada Não incomodou nada	Fraco Incomodou-me um pouco	Moderadamente Foi muito desagradável, mas consegui aguentar	Muito forte Quase não consegui aguentar
1	Dormência ou formigamento				
2	Calores				
3	Pernas bambas				
4	Incapaz de relaxar				
5	Medo do pior acontecer				
6	Tonteira ou cabeça leve				
7	Coração batendo forte ou acelerado				
8	Inquieto(a)				
9	Aterrorizado(a)				
10	Nervoso(a)				
11	Sensação de sufocamento				
12	Mãos tremendo				
13	Trêmulo(a)				
14	Medo de perder o controle				
15	Dificuldade de respirar				
16	Medo de morrer				
17	Assustado(a)				
18	Indigestão ou desconforto no abdômen				
19	Desmaio				
20	Face ruborizada				
21	Suores (não devido a calor)				

Quanto à qualidade de seu sono?					
Exagerado	Bom	Moderado	Ruim	Terror/Pesadelos	
1	2	3	4	5	
De que maneira sua saúde física ou problemas emocionais interferiram nas suas atividades sociais normais, em relação à família, amigos ou em grupo?					
De forma nenhuma	Ligeiramente	Moderadamente	Bastante	Extremamente	
1	2	3	4	5	
De que maneira sua saúde física ou problemas emocionais interferiram nas suas atividades de trabalho?					
De forma nenhuma	Ligeiramente	Moderadamente	Bastante	Extremamente	
1	2	3	4	5	
Quanta dor no corpo você teve?					
Nenhuma	Muito leve	Leve	Moderada	Grave	Muito grave
1	2	3	4	5	6

Figura 2: Primeira página da Ficha de Terapia Fluídica. Continua na próxima página.



DURANTE AS ÚLTIMAS 6 SEMANAS:						
Quanto a dor interferiu com seu trabalho normal (incluindo o trabalho dentro de casa)?						
De maneira alguma	Um pouco	Moderadamente	Bastante	Extremamente		
1	2	3	4	5		
Como você se sente e como tudo tem acontecido com você?						
	Todo o tempo	A maior parte do tempo	Uma boa parte do tempo	Alguma parte do tempo	Uma pequena parte do tempo	Nunca
a) Quanto tempo você tem se sentindo cheio de vigor, de vontade, de força?	1	2	3	4	5	6
b) Quanto tempo você tem se sentido uma pessoa muito nervosa?	1	2	3	4	5	6
c) Quanto tempo você tem se sentido tão deprimido que nada pode anima-lo?	1	2	3	4	5	6
d) Quanto tempo você tem se sentido calmo ou tranquilo?	1	2	3	4	5	6
e) Quanto tempo você tem se sentido com muita energia?	1	2	3	4	5	6
f) Quanto tempo você tem se sentido desanimado ou abatido?	1	2	3	4	5	6
g) Quanto tempo você tem se sentido esgotado?	1	2	3	4	5	6
h) Quanto tempo você tem se sentido uma pessoa feliz?	1	2	3	4	5	6
i) Quanto tempo você tem se sentido cansado?	1	2	3	4	5	6

ESCALA VISUAL DA DOR:

Onde está localizada sua dor? _____

O quanto você está sentido de dor neste momento?

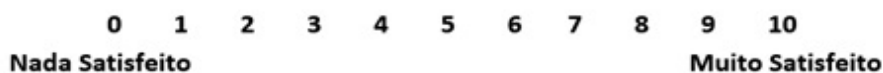


0 significa ausência total de dor e 10 o nível de dor máxima suportável pelo paciente.

SATISFAÇÃO COM O TRATAMENTO (a ser preenchido na última semana)

Quantos atendimentos (deste tratamento) você recebeu durante estas 6 semanas? _____

O quanto você está satisfeito com este tratamento?



Assinatura do Atendido: _____

Figura 3: Página final da Ficha de Terapia Fluídica. Ver texto para os detalhes.

dico-Espírita do Brasil, ainda não publicado.

A. Questionário utilizado no diálogo inicial do pri-

meiro encontro do ciclo:

- Cabeçalho: nome da pessoa atendida, data e dados de contato (telefone, Whatsapp, e-mail).



- Em geral você diria que sua saúde está: 1) Excelente; 2) Muito Boa; 3) Boa; 4) Ruim; ou 5) Muito Ruim.

As perguntas a seguir referem-se ao estado da pessoa durante as últimas seis semanas:

- Quanto foi incomodado? Para cada item numerado de 1 a 21, marque uma das opções: Nada (Não incomodou nada); Fraco (Incomodou-me um pouco); Moderadamente (Foi muito desagradável, mas consegui aguentar); Muito Forte (Quase não consegui aguentar). 1) Dormência ou formigamento; 2) Calores; 3) Pernas bambas; 4) Incapaz de relaxar; 5) Medo do pior acontecer; 6) Tonteira ou cabeça leve; 7) Coração batendo forte ou acelerado; 8) Inquieto(a); 9) Aterrorizado(a); 10) Nervoso(a); 11) Sensação de sufocamento; 12) Mãos tremendo; 13) Trêmulo(a); 14) Medo de perder o controle; 15) Dificuldade de respirar; 16) Medo de morrer; 17) Assustado(a); 18) Indigestão ou desconforto no abdômen; 19) Desmaio; 20) Face ruborizada; 21) Suores (não devido ao calor). Referência: Inventário de Ansiedade de Beck (CUNHA, 2001).
- Quanto à qualidade de seu sono? 1) Exagerado; 2) Bom; 3) Moderado; 4) Ruim; 5) Terror/Pesadelos.
- De que maneira sua saúde física ou problemas emocionais interferiram nas suas atividades sociais normais, em relação à família, amigos ou em grupo? 1) De forma nenhuma; 2) Ligeiramente; 3) Moderadamente; 4) Bastante; 5) Extremamente.
- De que maneira sua saúde física ou problemas emocionais interferiram nas suas atividades de trabalho? 1) De forma nenhuma; 2) Ligeiramente; 3) Moderadamente; 4) Bastante; 5) Extremamente.
- Como você se sente e como tudo tem acontecido com você? Para cada pergunta numerada de “a” a “i”, marque uma das opções: 1) Todo o tempo; 2) A maior parte do tempo; 3) Uma boa parte do tempo; 4) Alguma parte do tempo; 5) Uma pequena parte do tempo; 6) Nunca. a) Quanto tempo você tem se sentido cheio de vigor, de vontade, de força? b) Quanto tempo você tem se sentido uma pessoa muito nervosa? c) Quanto tempo você tem se sentido tão deprimido que nada pode animá-lo? d) Quanto tempo você tem se sentido calmo ou tranquilo? e) Quanto tempo você tem se sentido com muita energia? f) Quanto tempo você tem se sentido desanimado ou abatido? g) Quanto tempo você tem se sentido esgotado? h) Quanto tempo você tem se sentido uma pessoa feliz? i) Quanto tempo você tem se sentido cansado?

- Quanta dor no corpo você teve? 1) Nenhuma; 2) Muito leve; 3) Leve; 4) Moderada; 5) Grave; 6) Muito grave.
- Quanto a dor interferiu com seu trabalho normal (incluindo o trabalho dentro de casa)? 1) De maneira alguma; 2) Um pouco; 3) Moderadamente; 4) Bastante; 5) Extremamente.
- Onde está localizada sua dor?

As perguntas a seguir referem-se ao estado da pessoa no momento:

- O quanto você está sentindo de dor neste momento? 0 significa ausência total de dor e 10 o nível de dor máxima suportável pelo paciente.
- EVA - Escala Visual Analógica para Dor (TEIXEIRA *et al.*, 1994).

Assinatura do atendido.

- B. Ficha de acompanhamento utilizada nos diálogos inicial e final, do segundo ao quinto encontro do ciclo:

- Cabeçalho: nome do atendido, data e dia do ciclo (número do encontro).
- Diálogo inicial: breve texto relatando apenas dados ou mudanças significativas da pessoa, durante a semana.
- Diálogo final: breve texto relatando apenas dados ou mudanças significativas da pessoa, ao longo do tratamento ocorrido naquele dia.

- C. Questionário utilizado no diálogo final do sexto e último encontro do ciclo:

Idem ao questionário A, com acréscimo das seguintes perguntas:

- Quantos atendimentos (deste tratamento) você recebeu durante estas 6 semanas? Informar um número entre 1 e 6.
- O quanto você está satisfeito com este tratamento? Assinalar um número entre 0 (Nada Satisfeito) e 10 (Muito Satisfeito).

III RESULTADOS E DISCUSSÃO

A amostra selecionada para a pesquisa compreendeu 50 indivíduos que foram atendidos pelo Grupo Fonte Viva, durante o período de coleta de dados. Deste total, apenas 37 casos foram considerados válidos para análise, porque os seus questionários foram preenchidos tanto no início do primeiro dia de atendimento, como também ao final do último dia do ciclo de atendimento, permitindo, assim, a comparação.

A amostra contém predominantemente pessoas do sexo feminino (71%). A idade média dos indivíduos é 45 anos, sendo a distribuição por faixas etárias bem variada: até 29 anos (21%); de 30 a 59 anos (61%); de 60 anos ou mais (18%). A maioria (61%) possui escolaridade



Tabela I: Sumário das estatísticas de atendimentos realizados no período de 01/12/2016 a 13/04/2017 no Grupo Fonte Viva. Indicadores de saúde geral, ansiedade, bem-estar, qualidade de vida e dor. A escala mostra a melhor e a pior nota possível para cada indicador; df é o número de respostas válidas; média inicial e final são as notas médias calculadas antes e depois do ciclo de Terapia Fluídica; diferenças pareadas mostram o comparativo entre inicial e final. Os números em vermelho indicam os casos em que as médias inicial e final não apresentaram diferenças pareadas estatisticamente significativas ($p < 0,05$).

Indicadores de Bem-Estar		Escala		Média Inicial	Média Final	Diferenças Pareadas			t	df	p
		Melhor	Pior			Média	Desvio Padrão	Erro Padrão da Média			
1	Saúde Geral	1	5	3,4118	2,3529	1,0588	1,0993	0,1885	5,6160	33	0,0000
2	Inventário de Ansiedade de Beck	1	4	2,0687	1,5182	0,5505	0,6312	0,1038	5,3051	36	0,0000
2.01	Dormência ou Formigamento	1	4	1,8857	1,6000	0,2857	0,9873	0,1669	1,7120	34	0,0960
2.02	Calores	1	4	2,0000	1,5588	0,4412	1,1855	0,2033	2,1699	33	0,0373
2.03	Pernas bambas	1	4	1,6452	1,5484	0,0968	0,9436	0,1695	0,5710	30	0,5722
2.04	Incapaz de relaxar	1	4	2,8182	1,7576	1,0606	0,9981	0,1737	6,1043	32	0,0000
2.05	Medo do pior acontecer	1	4	2,5625	1,6250	0,9375	1,1622	0,2055	4,5630	31	0,0001
2.06	Tonteira ou cabeça leve	1	4	2,1290	1,5806	0,5484	1,0595	0,1903	2,8818	30	0,0072
2.07	Coração batendo forte ou acelerado	1	4	2,2188	1,5000	0,7188	1,2504	0,2210	3,2516	31	0,0028
2.08	Inquieto(a)	1	4	2,7500	1,7813	0,9688	1,3316	0,2354	4,1154	31	0,0003
2.09	Atemorizado(a)	1	4	1,9688	1,3125	0,6563	1,0352	0,1830	3,5862	31	0,0011
2.10	Nervoso(a)	1	4	2,5313	1,7500	0,7813	1,0994	0,1943	4,0199	31	0,0003
2.11	Sensação de sufocamento	1	4	2,1143	1,3143	0,8000	1,2319	0,2082	3,8418	34	0,0005
2.12	Mãos tremendo	1	4	1,7813	1,4063	0,3750	0,8707	0,1539	2,4364	31	0,0208
2.13	Trêmulo(a)	1	4	1,6970	1,3939	0,3030	1,0150	0,1767	1,7150	32	0,0960
2.14	Medo de perder o controle	1	4	2,3636	1,7273	0,6364	1,2201	0,2124	2,9962	32	0,0052
2.15	Dificuldade de respirar	1	4	2,0909	1,3636	0,7273	1,3293	0,2314	3,1429	32	0,0036
2.16	Medo de morrer	1	4	1,8182	1,2727	0,5455	0,8693	0,1513	3,6045	32	0,0010
2.17	Assustado(a)	1	4	2,0323	1,4194	0,6129	1,2564	0,2257	2,7161	30	0,0109
2.18	Indigestão ou desconforto no abdômen	1	4	2,3235	1,6765	0,6471	1,0698	0,1835	3,5269	33	0,0013
2.19	Desmaio	1	4	1,1875	1,0938	0,0938	0,7771	0,1374	0,6825	31	0,5000
2.20	Face ruborizada	1	4	1,2353	1,1765	0,0588	0,6001	0,1029	0,5716	33	0,5715
2.21	Suores (não devido a calor)	1	4	1,7647	1,4118	0,3529	1,0410	0,1785	1,9768	33	0,0565
3	Qualidade do Sono	2	5	3,3333	2,5278	0,8056	1,2380	0,2063	3,9043	35	0,0004
4	Interferência da Saúde nas Atividades Sociais	1	5	3,2857	2,2286	1,0571	1,3272	0,2243	4,7124	34	0,0000
5	Interferência da Saúde nas Atividades Laborais	1	5	3,0556	1,9444	1,1111	1,2370	0,2062	5,3894	35	0,0000
6	Qualidade de Vida	1	6	3,8877	2,5571	1,3306	1,1537	0,1950	6,8232	34	0,0000
6.a	Sentindo-se cheio de vigor, de vontade, de força	1	6	4,2941	3,0294	1,2647	1,2627	0,2166	5,8401	33	0,0000
6.b	Sentindo-se uma pessoa muito nervosa	1	6	3,6286	2,1143	1,5143	1,5973	0,2700	5,6087	34	0,0000
6.c	Sentindo-se tão deprimido que nada pode animá-lo	1	6	3,3529	1,8529	1,5000	1,9267	0,3304	4,5396	33	0,0001
6.d	Sentindo-se calmo ou tranquilo	1	6	4,1875	2,5938	1,5938	1,4337	0,2534	6,2884	31	0,0000
6.e	Sentindo-se com muita energia	1	6	4,2857	3,1143	1,1714	1,4650	0,2476	4,7306	34	0,0000
6.f	Sentindo-se desanimado ou abatido	1	6	3,8485	2,3636	1,4848	1,4169	0,2466	6,0201	32	0,0000
6.g	Sentindo-se esgotado	1	6	3,6571	2,2857	1,3714	1,5920	0,2691	5,0964	34	0,0000
6.h	Sentindo-se uma pessoa feliz	1	6	3,8286	2,7429	1,0857	1,7552	0,2967	3,6595	34	0,0008
6.i	Sentindo-se cansado	1	6	3,9429	2,8857	1,0571	1,5707	0,2655	3,9817	34	0,0003
7	Dor - Escala Visual Analógica (EVA)	0	10	4,0278	1,8611	2,1667	2,9032	0,4839	4,4778	35	0,0001
7.a	Dor no Corpo	1	6	3,5313	2,5313	1,0000	1,7598	0,3111	3,2146	31	0,0030
7.b	Interferência das Atividades Laborais	1	5	2,9091	1,7879	1,1212	1,5157	0,2638	4,2494	32	0,0002

de nível superior completo ou pós-graduação. Apenas 21% são casados ou possuem união estável. A maioria declarou-se espírita (54%) ou católico (26%). As queixas

de dores reportadas pelos indivíduos não se concentraram sobre um tópico específico. Os pontos mais citados, não exclusivamente, foram: cabeça (28%), ombro (24%), pescoço (20%), abdômen (16%), lombar (16%). Houve



menções pontuais a dores na alma e nas emoções.

Os dados foram tabulados em planilhas eletrônicas e submetidos ao processamento estatístico pelo programa IBM SPSS - *Statistical Package for Social Sciences*. Na Tabela I encontra-se o sumário das médias e desvios-padrão de cada um dos indicadores. Foram consideradas estatisticamente significantes as diferenças pareadas com $p < 0,05$.

Antes de iniciar o ciclo de Terapia Fluídica, a nota média das respostas à primeira questão levantada no questionário, sobre o que pensavam os atendidos sobre a sua saúde geral, foi de 3,41. A escala varia de 1 (excelente) a 5 (muito ruim). Este resultado indica, portanto, que a maioria (77%) considerava, até então, a sua saúde entre mediana e ruim. Ao final do ciclo de Terapia Fluídica, houve uma mudança significativa nas respostas que os atendidos deram a esta mesma pergunta. A nota média passou para 2,35. Isto indica que a maioria (79%) dos respondentes considerava que a sua saúde geral estava, no final, entre mediana e muito boa. Apenas um respondente manteve a nota 4 (ruim); todos os que tinham nota 5 (muito ruim) passaram a 3 ou melhor. A diferença média entre as notas foi de 1,06 ponto para melhor, sendo que o máximo que esta amostra permitiria, se todos atingissem o nível excelente, seria 2,41 pontos. A grande maioria (68%) atribuiu uma nota melhor à sua saúde geral no final do ciclo de Terapia Fluídica e apenas dois indivíduos (6%) atribuíram nota pior.

A percepção de melhora dos atendidos também é consistente no quesito de intensidade da dor. A última pergunta do questionário respondida antes de iniciar o ciclo de Terapia Fluídica era sobre qual o nível de intensidade de dor sentida no momento. A escala EVA varia de zero (ausência total de dor) a 10 (dor máxima suportável). Na avaliação antes do ciclo, a nota média foi 4,03 e, ao final, a nota média melhorou para 1,86. A melhora média na nota foi de 2,17 pontos, sendo que o máximo que esta

amostra permitiria, se todos atingissem a ausência total de dor, seria 4,03 pontos. A melhora também foi consistente entre os indivíduos que apresentavam dor aguda (nota 8 ou maior). Entre este grupo, que correspondia a 14% da amostra, a melhora variou entre 4 e 8 pontos na escala EVA. A grande maioria dos indivíduos da amostra (69%) atribuiu uma nota melhor ao seu nível de dor no final do ciclo de Terapia Fluídica e apenas 14% atribuíram nota pior.

No quadro dos 21 sintomas do Inventário de Ansiedade de Beck, houve uma pequena melhora. O *score* médio dos 21 itens já era baixo: 2,04, sendo que a escala varia de 1 (nada) a 4 (muito forte). Ao final do ciclo de Terapia Fluídica, o *score* médio passou a 1,49, com uma redução média de 0,55 ponto, enquanto a redução máxima possível seria 1,04 ponto. Importante ressaltar que, dos 21 itens avaliados, apenas 6 não apresentaram diferença estatisticamente significativa ($p < 0,05$). Todos os 15 demais itens apresentaram melhora significativa, assim como o *score* médio que engloba todos os itens também apresentou.

Na questão da qualidade do sono, a melhor nota desejada é 2 (bom), uma vez que a nota 1 (exagerado) não é desejável. A média das notas era de 3,33 pontos, antes do ciclo. Ao final do ciclo, a nota média passou para 2,53 pontos. Isto representa uma melhora significativa de 0,80 ponto, onde o máximo possível seria 1,33 ponto.

No indicativo da interferência das questões de saúde nas atividades sociais, numa escala de 1 (nenhuma) a 5 (extremamente), a melhora foi da nota 3,29 para 2,23, representando uma redução de 1,06 ponto, quando a redução máxima possível seria de 2,29 pontos.

No indicativo da interferência das questões de saúde nas atividades laborais, na mesma escala citada, a melhora da nota foi de 3,06 para 1,94, representando uma redução de 1,11 ponto, quando a redução máxima possível seria de 2,06 pontos.

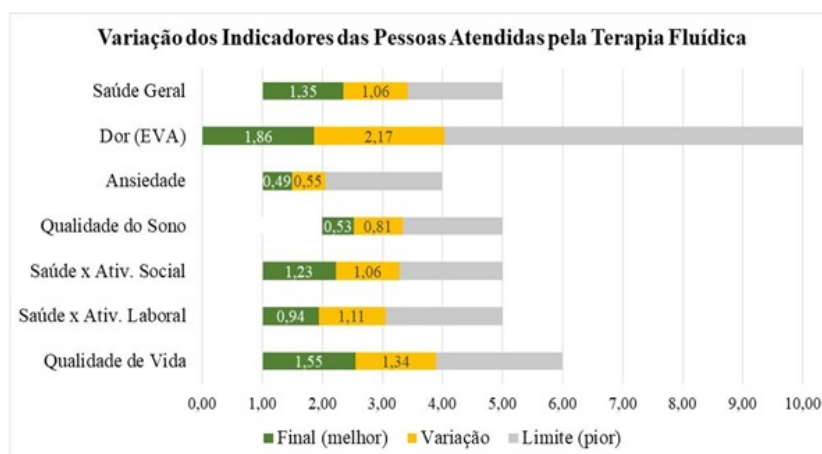


Figura 4: A escala de cada grupo de indicadores cobre o intervalo entre as notas melhor e pior, de acordo com a Tabela I. O trecho na cor cinza representa o limite da pior nota possível. O trecho em verde representa o limite da melhor nota possível. O trecho em amarelo representa a variação positiva das médias inicial de final de cada grupo de indicadores.



No quadro de 9 sintomas relacionados a qualidade de vida, houve uma melhora significativa em relação à nota ideal. O *score* médio teve de ser normalizado, uma vez que, para os itens “a”, “d”, “e” e “h”, a melhor nota possível seria 1 (todo o tempo), ao passo que, para os itens “b”, “c”, “f”, “g” e “i”, a melhor nota possível seria 6 (nunca). O *score* médio dos 9 itens baixou a distância média da nota ideal, de 2,89 para 1,55 ponto, melhorando 1,34 ponto, onde a melhora máxima possível seria de 2,89 pontos, numa escala de 1 a 6.

É importante mencionar os indicadores de frequência ao ciclo de Terapia Fluídica e de satisfação dos atendidos, em relação ao serviço prestado pelo Grupo Fonte Viva. Dentro da amostra desta pesquisa, o índice médio de frequência foi de 5,11 encontros semanais, sendo a frequência mínima encontrada de 4 encontros e a máxima de 6 encontros (100%) no ciclo.

A nota média de satisfação foi de 9,76, numa escala de zero a dez. Esta avaliação vai ao encontro dos indicadores de percepção de melhora das pessoas atendidas.

Na escala da Figura 4 acima, o ponto mais à esquerda na faixa verde representa a melhor nota possível; o ponto mais à direita na faixa cinza representa a pior nota possível; e o ponto mais à direita na faixa amarela representa a nota antes do atendimento com a Terapia Fluídica. Podemos notar que todos os principais indicadores apresentaram variações para melhor, de 44% (Saúde Geral) a 60% (Qualidade do Sono). Dos indicadores secundários que não estão representados no gráfico acima, 26 apresentaram melhora significativa e apenas 6 não apresentaram melhora estatisticamente significativa, conforme apresentado na Tabela I.

IV CONCLUSÕES

Apresentamos um instrumento de avaliação, cujo objetivo é investigar indicadores da Terapia Fluídica e seus reflexos no bem-estar dos indivíduos, incluindo saúde geral, ansiedade, qualidade de vida e dor. Selecionamos como amostra de pesquisa as pessoas que procuram o Atendimento Espiritual na Comunidade Espírita Esperança, em Vitória, ES, e são atendidas pelo Grupo Fonte Viva, em seis encontros semanais. Os critérios de triagem utilizados pela instituição são a presença de indícios de problemas físicos cuja causa não se consegue diagnosticar, ou que persistem mesmo após tratamento médico; sinais de ansiedade ou depressão. Aplicando o instrumento de avaliação antes do início do tratamento de Terapia Fluídica, e após a conclusão do ciclo de seis encontros semanais de tratamento, constatamos que os principais indicadores pesquisados mostraram melhoras estatisticamente significativas.

Ainda que os resultados sejam significativos, cabe tecer algumas ressalvas e considerações. Primeiramente, devemos lembrar que estes indicadores não se aplicam ao universo de toda a população do país. A amostra pesquisada possui uma característica bem peculiar, por ser composta exclusivamente por indivíduos com algum mal-estar físico ou espiritual e que aceitam, de bom grado,

os procedimentos da instituição espírita. Este nível de aceitação possivelmente possui correlação com o grau de sucesso da terapia. Outro ponto a ser considerado é o tamanho da amostra. Estender a pesquisa a um número maior de indivíduos permitirá a obtenção de indicadores mais precisos.

Por fim, não menos importante é o cuidado para não assumirmos uma relação direta de causa e efeito a partir do cenário pesquisado. O que se pode cogitar são indícios de uma correlação entre variáveis de melhoria de bem-estar na população que passa pelo atendimento do Grupo Fonte Viva. Trabalhos futuros deverão ampliar o espectro e o tamanho da população pesquisada, procurando estabelecer mecanismos que permitam controlar variáveis e isolar fatores que afetem a correlação entre as variáveis envolvidas neste fenômeno, tais como: efeito placebo, autossugestão, terapias concomitantes, entre outros.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos aos integrantes do Grupo de Pesquisa Lampejo, do qual os autores deste trabalho também fazem parte, pela colaboração na pesquisa: Ana Cristina S. S. Carneiro, Antonio M. Takahashi, Claudia V. Galvão, Dulce Vivancos, Everaldo S. Sousa, Karla D. Bernardi, Louise V. Faria, Viviane E. Ribeiro, Wallace F. Neves. Agradecemos aos integrantes do Grupo Fonte Viva pela operacionalização da coleta de dados para a pesquisa. Agradecemos à professora Teresa C. J. Carneiro pelo processamento das estatísticas.

REFERÊNCIAS

- BENOR, Daniel J. 2001. *Spiritual Healing: Scientific validation of a healing revolution*, vol. 1. Wholistic Healing Publications.
- BIROCCO, Nadia *et al.* 2012. The effects of Reiki therapy on pain and anxiety in patients attending a day oncology and infusion services unit. *American Journal of Hospice and Palliative Medicine* **29**, p. 290-294.
- CUNHA, J. *Manual das versões em português das escalas Beck*. Casa do Psicólogo, São Paulo, SP.
- DELANNE, F. M. Gabriel. 1885. *O Espiritismo perante a Ciência*. Tradução de Julieta Leite, do original francês de 1885. Editora Conhecimento, 2009, Limeira, SP.
- DELEUZE, J. P. François. 1825. *Instruction Pratique sur le Magnétisme Animal*. Dentu, p. 26, Paris.
- FEB, Federação Espírita Brasileira. 2006. *Orientação ao Centro Espírita: texto aprovado pelo Conselho Federativo Nacional em 2006*. Disponível em: <http://www.febnet.org.br/ba/file/Downlivros/orienta.pdf>. Acesso em: 30 de abril de 2017. p. 31-54.
- KARDEC, Allan. 1868. *A Gênese: os milagres e as predições segundo o espiritismo*. Tradução de Guillon Ribeiro, do original francês de 1868. 53ªed. FEB, Brasília, DF, 2013.
- KELLER, Elizabeth; BZDEK, Virginia M. 1986. Effects of therapeutic touch on tension headache pain. *Nursing Research* **35**, p. 101-105.
- LUCCHETTI, Giancarlo, *et al.* 2013. Effect of spiritist "passe"(spiritual healing) on growth of bacterial cultures. *Complementary Therapies in Medicine* **21**, p. 627-632.



MESMER, Franz F. A. 1779. *Mémoire sur la Découverte du Magnétisme Animal*. Didot, Paris.

PALHANO Jr, L. 1998. *Transe e Mediunidade: instruções espíritas para a prática da mediunidade*. Lachâtre, Niterói, RJ.

PALHANO Jr., L.; SOUZA, Dalva S. 1993. *Magnetismo Curador: instruções para o passe*. FESPE, Vitória, ES.

TEIXEIRA, Manoel J. *et al.* 1994. *Dor: conceitos gerais*. Limay, São Paulo, SP.

TITLE AND ABSTRACT IN ENGLISH

Fluidic Therapy: Introducing an Assessment Tool

Abstract: We define *Fluidic Therapy* as the systematic application of human-spiritual magnetism to improve the physical and spiritual welfare of any individual, as part of the *Spiritual Care at the Spiritist Center*, described by FEB. A large number of oral reports attest the benefits for people submitted to the Fluidic Therapy. This paper presents an assessment tool for the evaluation of the Fluidic Therapy, and analyzes the data collected at a spiritist institution in Vitória, ES, Brazil. We investigated indicators of Fluidic Therapy by the attended people's perception of well-being, including general health, anxiety, quality of life and pain. We selected as research subjects the people who seek spiritual care at a spiritist institution and who show one or more of the following symptoms: anxiety or depression aspects, physical problems not responding to medical treatment, or whose cause is not clearly diagnosed. Applying the assessment tool before the beginning of the Fluidic Therapy and after completing the cycle of six weekly sessions, we found that the main indicators surveyed showed statistically significant improvements ($p < 0.05$) by factors from 44% to 60%.

Keywords: Fluidic therapy; human-spiritual magnetism; spiritist pass.
